



РОССИЙСКИЙ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ISSN 0204-3475 (Print) ISSN 2500-2546 (Online)

☰ Меню Архив

[Главная](#) > [Архив](#) > [Том 34, № 1 \(2026\)](#) > [Способ эндоскопической остановки
гастродуоденального кровотечения вследствие аорто-дуоденального свища](#)

Способ эндоскопической остановки гастродуоденального кровотечения вследствие аорто-дуоденального свища



- **Авторы:** [Чередников Е.Ф.¹](#), [Черных А.В.¹](#), [Кашурникова М.А.¹](#), [Баранников С.В.¹](#),
[Боховитинов А.Е.²](#), [Прохоров Г.В.²](#), [Иванов А.А.^{1,3}](#), [Слюсарева Е.Е.¹](#)
- **Учреждения:**
 1. Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко
 2. Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1
 3. Воронежская областная клиническая больница № 1
- **Выпуск:** Том 34, № 1 (2026)
- **Страницы:** 117-126
- **Раздел:** [Клинические случаи](#)
- **Статья получена:** 05.03.2025
- **Статья одобрена:** 03.06.2025
- **Статья опубликована:** 31.03.2026
- **URL:** <https://journals.eco-vector.com/pavlovj/article/view/676858>
- **DOI:** <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ676858>
- **EDN:** <https://elibrary.ru/SSKXKO>
- **ID:** 676858



Цитировать

Полный текст



Открытый доступ



Доступ предоставлен



Доступ платный или только для подписчиков



(RUSSIAN)



(ENGLISH)

Аннотация

Обоснование. Аорто-дуоденальный свищ (АДС) является крайне редкой патологией, согласно литературным данным, заболевание встречается в 0,04–0,07% наблюдений. Это патологическое сообщение между аортой и двенадцатиперстной кишкой обусловлено топографо-анатомическими особенностями взаиморасположения брюшного отдела аорты и двенадцатиперстной кишки. Самым частым осложнением АДС является массивное желудочно-кишечное кровотечение, сопровождающееся крайне высокой летальностью (до 100% — при отсутствии лечения и 30–40% — при хирургическом лечении).

В данной статье описан случай лечения АДС, осложненного кровотечением, путем применения разработанного способа эндоскопического гемостаза, заключающегося в сочетанном использовании двух порошкообразных гемостатиков и гранулированного цитопротективного сорбента.

Заключение. Предложенный способ эндоскопической остановки гастродуоденального кровотечения позволил обеспечить надежный гемостаз, предотвратить рецидив геморагии, выиграть время для диагностического поиска и успешного выполнения радикальной операции в условиях специализированного сосудистого центра.

Ключевые слова

аорто-дуоденальный свищ, желудочно-кишечное кровотечение, эндоскопический гемостаз, альгинатный полимерный полисахаридный гемостатический гидрогель, полигемостат, гранулированные сорбенты

Полный текст



Об авторах

Евгений Федорович Чередников

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко

Email: facult-surg.vsmuburdenko@yandex.ru

ORCID iD: [0000-0001-7521-0211](https://orcid.org/0000-0001-7521-0211)

SPIN-код: [7683-5973](https://www.spin-portal.ru/7683-5973)

д-р мед. наук, профессор

Россия, Воронеж

Александр Васильевич Черных

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко

Email: chernyh@vrngmu.ru

ORCID iD: [0000-0002-6281-0020](https://orcid.org/0000-0002-6281-0020)

SPIN-код: [8444-7010](https://www.spin-portal.ru/8444-7010)

д-р мед. наук, профессор

Россия, Воронеж

Мария Анатольевна Кашурникова

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко

Автор, ответственный за переписку.

Email: kachurnicova@bk.ru

ORCID iD: [0009-0003-9929-4730](https://orcid.org/0009-0003-9929-4730)

SPIN-код: [9838-2777](#)

Россия, Воронеж

Сергей Викторович Баранников

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко

Email: svbarannikov@rambler.ru

ORCID iD: [0000-0002-2620-9836](#)

SPIN-код: [1193-6917](#)

канд. мед. наук, доцент

Россия, Воронеж

Алексей Евгеньевич Боховитинов

Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1

Email: docbarmaley@gmail.com

ORCID iD: [0009-0003-8174-1862](#)

SPIN-код: [9816-4619](#)

Россия, Воронеж

Глеб Владимирович Прохоров

Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1

Email: prokhorovgleb1977@gmail.com

ORCID iD: [0009-0007-1368-6100](#)

SPIN-код: [3475-3054](#)

Россия, Воронеж

Андрей Анатольевич Иванов

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко;

Воронежская областная клиническая больница № 1

Email: yonaviaa@yandex.ru

ORCID iD: [0000-0002-1507-5393](#)

SPIN-код: [5588-2292](#)

д-р мед. наук

Россия, Воронеж; Воронеж

Ева Евгеньевна Слюсарева

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко

Email: eslusareva@bk.ru

ORCID iD: [0009-0008-0462-7229](#)

SPIN-код: [1762-7590](#)

Россия, Воронеж

Список литературы

1. Kehagias D, Mulita F, Panagiotopoulos I, et al. Primary aortoenteric fistula: is endovascular repair the prime option? A review of the literature. *Kardiochir Torakochirurgia Pol.* 2022;19(4):220–225. doi: [10.5114/kitp.2022.122092](#). EDN: TGJDSV
2. Abdulgasanov RA, Gasymov EG. Aortoenteric fistula: causes, diagnosis, treatment, prevention. *Russian Journal of Surgery.* 2017;22(3):137–142. EDN: ZNOGYH
3. Panasyuk AI, Kyshtymov SA, Inozemcev EO, Grigoryev EG. Secondary aorto-duodenal fistula. Recurrent bleeding. Difficulties of topical diagnosis and tactical errors (case from clinical practice). *Challenges in Modern Medicine.* 2020;43(1):146–154. doi: [10.18413/2687-0940-2020-43-1-146-154](#). EDN: CYUONQ
4. Mavilia MG, Wu GY. Aortoenteric Fistula. *J Am Osteopath Assoc.* 2019;119(2):135. doi: [10.7556/jaoa.2019.022](#)
5. Rejab H, Fendri S, Bouzid A, et al. Primary aortoduodenal fistula presenting as a rare cause of upper gastrointestinal bleeding. *Clin Case Rep.* 2023;11(1):e6888. doi: [10.1002/ccr3.6888](#). EDN: KCJOGJ
6. Beuran M, Negoii I, Negoii RI, et al. Primary Aortoduodenal Fistula: First you Should Suspect it. *Braz J Cardiovasc Surg.* 2016;31(3):261–263. doi: [10.5935/1678-9741.20160049](#)

7. Styazhkina SN, Klimentov MN, Leonova AD, et al. Aorto-duodenal fistula (clinical cause). Problems of Modern Science and Education. 2017; (14):108–111. EDN: YJNEOF
8. Kulikovskiy VF, Karpachev AA, Soloshenko AV, et al. Clinical cases of rare bleeding of the upper sections of gastrointestinal tract. Nauchnyye Vedomosti Belgorodskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya: Meditsina. Farmatsiya. 2017;(19):118–126. EDN: ZHGTAH
9. Abderrahmane A, Retal H, Cannie M, et al. Diagnosis of an Occult Aortoenteric Fistula and Treatment of a Silent Threat. Cureus. 2025; 17(3):e80937. doi: [10.7759/cureus.80937](https://doi.org/10.7759/cureus.80937). EDN: FXBNRD
10. Calvo-García H, Herrera-Kok JH, Álvarez-Martínez A, et al. Aortoenteric fistulae and their multidisciplinary approach. Cir Cir. 2023;91(4):571–575. doi: [10.24875/ciru.21000702](https://doi.org/10.24875/ciru.21000702). EDN: ODCRSQ
11. Belov DV, Garbuzenko DV, Andrievskikh SI, Anufrieva SS. Aorto-digestive fistulas: a rare cause of gastrointestinal bleeding. Patologiya Krovoobrashcheniya i Kardiokhirurgiya. 2021;25(4):23–29. doi: [10.21688/1681-3472-2021-4-23-29](https://doi.org/10.21688/1681-3472-2021-4-23-29). EDN: QBDIQN
12. Ichita C, Sasaki A, Sumida C, et al. Clinical and endoscopic features of aorto-duodenal fistula resulting in its definitive diagnosis: an observational study. BMC Gastroenterol. 2021;21(1):45. doi: [10.1186/s12876-021-01616-9](https://doi.org/10.1186/s12876-021-01616-9). EDN: NLWMRE
13. Patent RUS No. 2618406. 03.05.2017. Byul. No. 13. Cherednikov EF, Kashurnikova MA, Litovkina TE, et al. Method to stop gastroduodenal bleeding. Available from: <https://patents.google.com/patent/RU2618406C1/ru>. EDN: KASAWL
14. Lazarenko VA, editor. Khirurgiya. Moscow: MIA, 2025. Vol. 1. (In Russ.)
15. Barannikov SV, Cherednikov EF, Polubkova GV, et al. First experience of using alginate polymer polysaccharide hemostatic hydrogel in complex endoscopic treatment of unstable gastroduodenal ulcer bleeding: Clinical cases. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2024;31(3):73–92. doi: [10.25207/1608-6228-2024-31-3-73-92](https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-3-73-92). EDN: VQMYLJ
16. Parhisenko YuA, Vorontsov AK, Kalashnik RS, Bezaltynnykh AA. Application of “Polygemostat” drug to ensure hemostasis in spontaneous rupture of cavernous liver hemangioma (clinical observation). Vestnik Smolenskoy Gosydarstvennoy Medicinskoy Akademii. 2016;15(4):72–76. EDN: XVHFPD
17. Derjaeva OG, Cherednikov EF. Multimodality therapy of erosive-ulcer gastroduodenal bleeding by patients in a multidisciplinary hospital. System Analysis and Management in Biomedical Systems. 2014;13(3):725–730. EDN: STEZFD

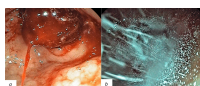
Дополнительные файлы

Доп. файлы

1. JATS XML

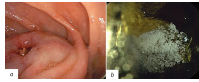
[Скачать](#)

2. Рис. 1. Первичная эзофагогастродуоденоскопия пациента Ч., 71 года, осмотр в белом свете: а — сгусток крови, тампонирующий луковицу двенадцатиперстной кишки; б — нанесение альгинатного полимерного полисахаридного гемостатического гидрогеля, Полигемостата® и гранулированного сорбента Анилодиовина® на фиксированный сгусток крови.



[Скачать](#) (298KB) [Метаданные](#)

3. Рис. 2. Повторная эзофагогастродуоденоскопия пациента Ч., 71 года, осмотр в белом свете: а — округлой формы язвенный дефект двенадцатиперстной кишки около 0,6 см в диаметре, глубиной не менее 5,0 мм, в области дна сгусток крови, некротические массы и остатки фрагментов пищи; б — нанесение альгинатного полимерного полисахаридного гемостатического гидрогеля, Полигемостата® и гранулированного сорбента Анилодиовина® на язвенный дефект.



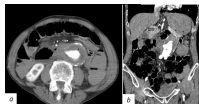
[Скачать](#) (275KB) [Метаданные](#)

4. Рис. 3. Повторная эзофагогастродуоденоскопия пациента Ч., 71 года, осмотр в белом свете: а — устье свищевого хода около 5 мм в диаметре с сукровичным отделяемым; б — обкалывание источника кровотечения раствором аминокaproновой кислоты с адрепалином; с — инфузия альгинатного полимерного полисахаридного гемостатического гидрогеля, Полигемостата® и гранулированного сорбента Анилодиовина® на источник кровотечения.



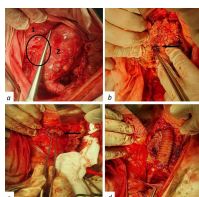
[Скачать](#) (151KB) [Метаданные](#)

5. Рис. 4. Компьютерная томограмма с внутривенным контрастированием (артериальная фаза) пациента Ч., 71 года: а — аксиальный срез; б — коронарный срез. Картина циркулярного расслоения стенки брюшного отдела аорты (показано стрелкой).



[Скачать](#) (153KB) [Метаданные](#)

6. Рис. 5. Ход оперативного вмешательства у пациента Ч., 71 года: а — в операционную рану выведена аневризма брюшного отдела аорты и зона аорто-дуоденального свища (показан овалом) с примыкающей двенадцатиперстной кишкой (1 — двенадцатиперстная кишка; 2 — аневризма брюшной аорты); б — вскрыт и удален аневризматический мешок; по медиальной стенке аневризмы обнаружено основание свищевого хода (обозначен стрелкой) между аортой и двенадцатиперстной кишкой; с — двенадцатиперстная кишка отделена от аорты; виден дефект стенки двенадцатиперстной кишкой (указан стрелкой), в отверстие свища введен пинцет; д — этап протезирования брюшного отдела аорты линейным протезом.



[Скачать](#) (295KB) [Метаданные](#)

Статистика

Просмотры

Аннотация: 55

PDF (Русский): 2

PDF (Английский): 1

Метрики статей

Просмотры PDF: 3



PlumX



Нет доступных показателей.

 **PLUMX** - [см. подробнее](#)

© Эко-Вектор, 2026

Ссылка на описание лицензии: https://eco-vector.com/for_authors.php#07



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № [ФС77-76803](#) от 24 сентября 2019 года.

Developed by ECO-VECTOR

Powered by EVESYST

